

がん薬物療法：各論4；肺がん、乳がん

●疫学

- ・近年（2003～2005年）の我が国における悪性新生物の部位別5年生存率は、胃癌、大腸癌は約60～70％であり、**肝臓癌、肺癌は約30％弱**。
- ・肺癌の治療法別の成績では、手術療法が非手術療法より圧倒的に優れているが、近年は分子標的薬などの開発により非手術でも長期生存例が見られるようになってきている。

●固形がんの治療

- ・手術療法、放射線療法、化学療法（抗がん剤）、ホルモン療法（乳癌、前立腺癌）、分子標的薬（上皮増殖因子阻害薬、血管新生阻害）、免疫チェックポイント阻害剤

○集学的治療

- ・外科療法、放射線療法、化学療法、ホルモン療法、免疫療法などのがんの治療を効果的に組み合わせて、治療成績を向上させる方法・治療方針。
- ・局所療法は、局所の治療効果は大きいが全身化した癌には無力。
- ・化学療法は、局所の治療効果は少ないが、全身を治療できる。

●乳がんの治療

○乳がん症状

- ・しこり、乳房痛、乳頭異常分泌。早期では無症状。
- ・検診、マンモグラフィーで発見される。
- ・**遺伝性乳がん・卵巣がん症候群**では、**BRCA1、BRCA2**などの遺伝子変異が見られる。

○臨床病期と治療方針（HBOC）

- ・0期、1期、2期までの早期乳がん、3A期までは、高い頻度で根治。
- ・3A、3B、3C期は局所進行乳がんであり、外科切除＋放射線＋薬物療法となる。（集学的治療）
- ・転移性乳がんなどの4期、根治不能場合は、延命と症状緩和。

○乳がんの全身治療と局所療法

●全身治療：抗がん剤化学療法、ホルモン療法、トラスツズマブ

- ・短所：局所の大きな腫瘍に対しては十分な効果がない。
- ・長所：遠隔転移、微小転移に対して有効である。

●局所療法：乳房温存療法＋放射線療法、乳房切除術

- ・短所：局所にとどまっている病変は完全に切除できる。
- ・長所：遠隔転移、微小転移には無力である。

○進行・再発乳がんの薬物療法の選択→乳がんの状態による。

- ・ホルモン感受性あり：**内分泌療法**
- ・ホルモン感受性なし、**HER2陽性**：**化学療法、抗HER2療法**
- ・ホルモン感受性なし、HER2陰性：**化学療法**

●内分泌療法

- ・エストロゲン製剤：乳がん細胞のホルモン受容体をブロック。閉経前・後に使用。
- ・アロマターゼ阻害薬：副腎、脂肪組織での女性ホルモン産生をブロックする。閉経後に使用。
- ・LH-RHアゴニスト：黄体ホルモンの放出を阻害することにより卵巣の女性ホルモン産生を阻害。閉経前に使用。

＊閉経前：LH-RHアゴニスト＋エストロゲン製剤。

＊閉経後：アロマターゼ阻害剤

○乳がんの薬物療法

- ・化学療法：細胞障害性化学療法：アンスラサイクリン系、タキサン系、フッ化ピリミジン系
- ・内分泌療法：抗エストロゲン剤：タモキシフェン、トレミフェン、フルベストラント
アロマターゼ阻害薬：アナストロゾール、レトロゾール、エキセメスタン
LH-RHアゴニスト：ゴセレリン、リュープロレリン
- ・CKD4/6阻害剤：内分泌治療と併用：バルボシクリブ
- ・分子標的薬剤：**抗HER2抗体**：**トラスツズマブ**、ペルツズマブ、T-DM1

⑥
・骨髄抑制
・口内炎
・下痢